

도수치료 채팅방 자주 묻는 질문

구성 빈도순 20문항, 각 질문에 근거와 함께 정리

근거 보건복지부 고시·질의응답 등 1차 자료, 관련 법령·기준

표기 범위

확정 1차 자료로 확인 **참고** 법령·기준으로 정리(개별 확인 권장) **미확인** 공식 답 없음

[참고]·[미확인] 항목은 심평원·해당 기관에 개별 확인이 필요합니다. 정부가 직접 답한 사항(단가·본인부담률·횟수 등)은 별도 정리본을 참고하세요.

Q 도수치료 채팅방 자주 묻는 질문

Q1 관리급여 도수(연 15회)는 실손 청구가 되나, 부지급될 수도 있나?

확정 청구된다. 다만 조건 미충족 시 거절 가능.

관리급여는 건강보험 급여라서 본인부담 95%분(약 41,660원)이 실손 급여 보장 대상이 된다. 1~4세대는 급여 자기부담률이 적용되어 부담이 오히려 줄 수 있고, 2026.5.6 나온 5세대는 도수치료를 보장에서 제외했다. 적응증·횟수 기준을 못 맞춘 진료는 지급이 거절될 수 있다.

근거: 금융위원회 실손 질의응답; 금융감독원 행정지도(행2026-41003); 5세대 실손 표준약관(2026.5.6)

Q2 실손 세대·통원 한도에 따라 실제 수령액이 어떻게 다른가?

참고 세대에 따라 크게 갈린다.

1~4세대는 급여 자기부담률만 부담하여 유리하고, 5세대는 도수치료가 보장에서 빠져 사실상 받지 못한다. 통원 한도와 최소 자기부담금(5세대는 1만~2만원 등)은 약관마다 달라 가입 약관을 직접 확인해야 한다.

근거: 금융위원회·금융감독원 실손 안내; 보험사 실손 약관

Q3 3.3% 프리랜서나 파트타임도 상근 인력으로 인정되어 도수를 할 수 있나?

확정 상근 물리치료사여야 한다. 세부 판단은 심평원 기준.

도수 시행자는 해당 요양기관에 상근하는 물리치료사여야 한다. 3.3% 프리랜서·파트타임의 상근 인정 세부 기준은 고시에 없고 심평원의 상근 판단을 따른다. 일반 물리치료 인력 산정에는 주 3일 이상·주 20시간 이상이면 0.5인으로 보는 기준이 있으나, 도수 상근 요건에 그대로 적용되는지는 확인이 필요하다.

근거: 고시 제2026-136호 도수치료 급여기준 사목; (참고) 이학요법료 인력 산정 기준

Q4 연 15회를 다 쓴 뒤 피로·권태 비급여 도수의 금액은 정해져 있나?

확정 표준 금액은 없고 병원이 정한다.

피로회복·체형교정 등 질환 치료 목적이 아닌 도수치료는 건강보험·실손이 적용되지 않는 비급여이므로(Q7·Q14), 가격은 의료기관이 자율로 정하며 정부가 정한 단가는 없다. 비급여 진료비는 모니터링 대상이다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q7·Q14

Q5 삭감되면 환자에게 환불해야 하나, 금액은 얼마인가?

확정 돌려줘야 하고, 사실상 병원이 부담한다.

심사에서 과다 본인부담이 확인되면 공단이 병원에 줄 요양급여비용에서 그 금액을 정산해 환자에게 환급한다. 환자가 낸 95%분(약 41,660원)도 환급 대상이라 병원은 인건비를 쓰고도 수익을 얻지 못한다.

근거: 국민건강보험법 제47조 및 과다본인부담금 환급 절차

Q6 무엇을 근거로 삭감하며 어떻게 다투나?

확정 고시 급여기준이 근거. 단계별로 다를 수 있다.

횡수·선행·기록 요건이 근거이며, 처방한 자·시행자·시행기법·시행부위·소요시간·치료효과평가를 적어 보존해야 한다. 이의가 있으면 심평원 재심사조정청구 → 이의신청·심판청구(건강보험분쟁조정위원회) → 행정소송으로 다툰다.

근거: 고시 제2026-136호 아목; 질의응답 Q27; 국민건강보험법 제87·88조

Q7 안면마비 전기자극치료(EST)도 선행 면제·도수 적용 대상인가?

확정 도수 대상이 아니다.

도수치료 급여는 근골격계 질환에만 인정되므로(Q4), 안면마비 전기자극치료(EST)는 도수가 아니라 별도의 전기자극 행위다. 즉시 도수가 가능한 선행 면제 대상은 소아 사경과 수술 후 관절운동범위 제한으로 한정되어(Q21) 안면마비는 포함되지 않는다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q4·Q21

Q8 수술 후 도수는 수술 후 몇 개월까지 선행 면제인가?

미확인 기간 상한은 정해져 있지 않다.

수술 후 관절운동범위 제한으로 시행하면 의사의 의학적 판단에 따라 즉시 도수가 가능하지만(Q21), 며칠·몇 개월까지인지는 고시·질의응답에 없어 의사의 판단과 기록으로 정한다. 퇴행성 질환 수술이 면제 대상인지도 공식 문서에 명시가 없다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q21; 고시 제2026-136호 아목

Q9 기존 도수 환자도 횡수가 리셋되나, 받은 횡수가 차감되나?

확정 7월 1일부터 새로 센다.

2026년은 7.1~12.31까지 15회(예외 24회)로 적용되고(Q11), 6.30까지 받은 도수는 비급여라 이 횡수에 합산되지 않는다. 7.1 이전에 받은 기본물리치료·단순재활치료는 선행으로 인정된다(Q19).

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q11·Q19

Q10 자보·산재 도수 횡수와 건강보험 도수 횡수는 따로 세나?

확정 따로 센다.

산재 도수는 7.1 진료분부터 건강보험 기준을 따라 **단가 43,850원, 주 2회·연 15회**로 바뀌고 산재 환자는 본인부담이 없다. **자보·산재는 도수치료관리시스템 제출 대상이 아니므로**(Q31) 건강보험 횡수와 합쳐지지 않는다. 자보 단가는 건강보험과 같게 정렬되나 횡수 기준은 자보 고시를 따로 확인해야 한다.

근거: 근로복지공단 산재 안내(2026.6.29); 질의응답 Q31; 국토부 자보 고시(제2025-369호)

Q11 비급여 도수를 하려면 면세사업자가 과세사업자로 전환해야 하나?

참고 **치료가 아닌 목적이면 과세 대상이 될 수 있다.**

의료기관 진료는 부가세 면세이지만, **피로·체형교정 같은 비치료 목적 비급여는 미용·성형처럼 과세**로 본다. 과세 진료를 하면 과세사업자로 전환(공급가의 10% 부가세 징수)해야 하고, 사업 개시 후 20일 안에 신청한다. 구체적 적용은 세무 확인이 필요하다.

근거: 부가가치세법 제26조 및 시행령; 국세청 미용·성형 부가세 과세 사례

Q12 도수치료와 일반 물리치료(급여)·국소주사를 같은 날 산정할 수 있나?

확정 일부만 같이 된다.

도수와 **마사지치료(사105)는 따로 받지 못하고**, 운동치료(사106·116)·재활기능치료(사130)와 같은 날 하면 둘 중 큰 항목만 인정된다. 외래에서 도수와 **국소주사(관절강내·신경간내주사·신경차단술 등)는 각 인정기준에 맞으면 같이 산정**된다.

근거: 고시 제2026-136호 다목·라목; 질의응답 Q17·Q22

Q13 크라이오·고주파(원백)·신장분사에 도수를 묶어도 되나, 실손이 되나?

참고 **권하지 않는다.**

급여 도수와 비급여를 같이 하는 것을 직접 막지는 않지만 **동시 시술은 별도 모니터링이 진행될 예정**이다(Q8). 비급여를 실손 받으려 도수에 끼워 넣으면 보험사 지급 거절·현장조사 위험이 있고, **급여 도수의 본인부담을 비급여로 둔갑시키면 부당청구**가 된다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q8; 국민건강보험법·의료법 부당청구 기준

Q14 타 병원에서 받은 선행 물리치료 4회는 어떻게 확인하나?

확정 **환자에게 서류를 받아 확인한다.**

선행치료는 한 병원에서만 채울 필요가 없고 **타 병원 시행분도 인정**된다(Q20). 다만 도수치료관리시스템은 **타 병원 도수 횡수만 보여 주고 선행 물리치료 이력은 조회되지 않으므로**(Q29·Q30), 환자에게 세부내역서나 진료기록을 받아 확인해야 한다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q20·Q29·Q30; 도수치료관리시스템 매뉴얼

Q15 한방 침·물리치료는 선행으로 인정되나, 도수 받는 날 병행할 수 있나?

확정 **한방은 선행으로 인정되지 않는다.**

선행치료는 이학요법로 **제1절 기본물리치료료·제2절 단순재활치료료 행위만 인정**하므로(마목, Q18), 한의사가 처방한 한방 물리치료·침은 코드 체계가 달라 선행이 되지 않는다. 같은 날 한방 병행은 양·한방 협진과 청구기준을 따로 확인해야 한다.

근거: 고시 제2026-136호 마목; 질의응답 Q18

Q16 과거(수개월·1년 전) 물리치료 이력도 선행으로 인정되나, 기간 제한은?

미확인 인정되지만 상한은 정해져 있지 않다.

7.1 이전에 받은 기본물리치료·단순재활치료도 선행으로 인정된다(Q19). 다만 얼마나 오래된 이력까지 인정하는지는 고시·질의응답에 명시가 없어 공식 기준이 확인되지 않는다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q19

Q17 4과 외 일반의·타과 의사도 처방할 수 있나?

확정 교육을 이수해야 가능하다.

도수는 정형·신경외과·재활의학·마취통증의학과 전문의나 관련 교육 이수 의사가 처방하고, 그 의사 또는 상근 물리치료사가 실시한다(사목, Q24). 교육과정 신설 전까지는 유예이고, 유예 동안의 처방 범위는 추후 보건복지부 안내를 따른다.

근거: 고시 제2026-136호 사목; 질의응답 Q24

Q18 도수치료를 하려면 무슨 교육을 언제·어디서 이수해야 하나?

확정 아직 정해지지 않았고 유예 중이다.

의사·물리치료사 교육과정은 대한의사협회 등 협의로 새로 만들 예정이며, 이수증 발급 단체 지정·준비기간이 필요해 추후 보건복지부 안내 때까지 유예된다. 이후에는 보건의료자원통합신고포털(hurb.or.kr)에 이수 여부를 신고한다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q24

Q19 6월에 도수와 같은 날 받은 물리치료도 선행으로 인정되나?

미확인 공식 문서에서 확인되지 않는다.

선행은 이학요법료 제1·2절 행위를 도수 시행 전에 2주(14일) 이상·4회 이상 시행하면 인정되지만(Q18), 도수와 같은 날 시행한 물리치료가 선행 횟수에 포함되는지는 명시가 없어 개별 확인이 필요하다.

근거: 심평원 질의응답 수정본(2026.6.29) Q18(같은 날 포함 여부 명시 없음)

Q20 관리급여 도수는 받을 때마다 의사 진료(진찰료)를 동반해야 하나?

확정 처방은 필요하지만 매번 진찰료가 필수는 아니다.

도수는 4과 전문의나 교육이수 의사의 처방이 있어야 하나(사목), 시행할 때마다 진찰료를 함께 받아야 한다는 규정은 없다. 진찰료는 실제 진찰을 본 경우에만 따로 산정한다.

근거: 고시 제2026-136호 사목